

CAMBIOS PROPUESTOS EN EL PDF DEL PROYECTO ALDIMI PREDICT

1. Reemplazar el enfoque "pacientes oncologicos prioritarios" por una delimitacion clara: pacientes pediatricos con cancer de medula osea.
2. Reescribir el objetivo general para que no parezcan dos proyectos separados. Nuevo enfoque: integrar la priorizacion clinica de pacientes con cancer de medula osea con la prediccion de demanda de insumos clinicos y alimentos esenciales.
3. Ajustar el resumen ejecutivo. Ahora debe explicar que el modelo clinico mide presion asistencial, el modelo logistico anticipa recursos asociados a esa presion y ambos forman un solo sistema preventivo.
4. Cambiar el problema central. En vez de hablar de severidad clinica y logistica como ejes paralelos, plantearlo como falta de articulacion entre prioridad clinica y planificacion de abastecimiento para pacientes con cancer de medula osea.
5. Reescribir los objetivos especificos para que sigan un flujo unico: clasificar prioridad asistencial en cancer de medula osea, predecir demanda de insumos y alimentos, detectar riesgo de quiebre de stock e integrar ambas salidas en una herramienta de apoyo.
6. Cambiar la formulacion de la integracion operativa de los modelos. Debe quedar explicito que la clasificacion clinica no es un modulo independiente, sino la senal que alimenta la planificacion logistica.
7. Actualizar el alcance del proyecto. Debe decir que el sistema se enfoca en pacientes pediatricos con cancer de medula osea, recursos vinculados a su atencion e insumos clinicos y alimentos esenciales.
8. Reemplazar la descripcion del dataset logistico. Ya no deberia centrarse en el dataset pequeno de inventario con 990 registros como base principal. Debe incorporar el nuevo dataset logistico adaptado de FreshRetailNet con muestra secuencial de mayor volumen.
9. Explicar que el nuevo dataset logistico fue adaptado semanticamente. Es decir: los product_id anonimizados fueron recodificados y se asignaron nombres visibles de productos clinicos y alimentos para alinear el caso de uso con ALDIMI.
10. Actualizar la tabla de fuentes de datos seleccionadas. Debe reflejar dataset clinico SEER y dataset logistico FreshRetailNet adaptado.
11. Reescribir la parte de caracteristicas del eje logistico. Ahora las variables importantes son dt, product_id, sale_amount, stock_hour6_22_cnt, discount, holiday_flag, activity_flag y variables temporales derivadas como venta_lag_1, venta_lag_7, venta_promedio_7d y stock_lag_1.
12. Eliminar o reducir el peso del argumento basado en el 51.92 por ciento de error en fechas del dataset viejo, porque pierde centralidad si el nuevo eje logistico usa otra fuente y otra estructura.

13. Replantear la seccion de riesgos logísticos. Nuevos riesgos: productos anonimizados, necesidad de recodificación semántica, posible desfase entre ventas y stock y necesidad de crear rezagos temporales.
14. Reemplazar el discurso de generación de datos sintéticos médicos como base del sistema. Si aun se menciona, debe quedar como etapa previa o prototipo, no como base final del modelo logístico actual.
15. Ajustar los objetivos de minería de datos. El modelo logístico ya no debería presentarse como simple regresión tabular aislada, sino como predicción de demanda con variables temporales.
16. Cambiar el criterio de éxito técnico del modelo logístico. Conviene revisar si mantendrán MAPE menor a 15 por ciento o si usaran MAE, RMSE y R cuadrado con división cronológica.
17. Corregir cualquier mención a que el modelo logístico hace forecasting temporal puro si no corresponde. Debe decirse con precisión: modelo de machine learning para predicción de demanda con variables temporales derivadas.
18. Reescribir la parte del eje clínico para que la enfermedad quede explícita. No dejarlo como dataset de enfermedades o dataset oncológico general. Debe decir: dataset clínico para priorización de pacientes con cáncer de médula ósea.
19. Actualizar la narrativa del impacto operativo. Debe explicarse que un aumento de pacientes priorizados con cáncer de médula ósea incrementa la necesidad esperada de recursos clínicos y alimentarios, y por eso la logística se anticipa a partir de la señal clínica.
20. Cambiar las referencias a productos esenciales. Ahora deben distinguirse dos grupos: productos clínicos y alimentos de canasta básica y apoyo nutricional.
21. Actualizar la sección de EDA logístico. Incluir distribución de demanda, top productos clínicos, top alimentos, relación demanda vs stock previo, relación demanda vs descuento y disponibilidad horaria resumida.
22. Ajustar la explicación de `hours_stock_status` y `stock_hour6_22_cnt`. Si se menciona en el informe, debe aclararse que son variables operativas agregadas y no equivalen directamente a stock de cierre.
23. Agregar una explicación metodológica sobre la columna `name_products` y el catálogo adaptado. Debe quedar claro que los nombres visibles son etiquetas de presentación para el caso ALDIMI.
24. Reescribir la conclusión de viabilidad analítica. Debe afirmar que la viabilidad del proyecto proviene de conectar criticidad clínica en cáncer de médula ósea con presión de demanda sobre productos clínicos y alimentos.

25. Cambiar el nombre conceptual del sistema si hace falta, para que refleje mejor la integracion: sistema integrado de priorizacion clinica y abastecimiento preventivo.

26. En la demo final o entregable, cambiar la promesa. No solo visualizar prioridad clinica y demanda, sino visualizar como la prioridad clinica esperada afecta la necesidad preventiva de insumos y alimentos.

27. Revisar todas las paginas donde aparezca pacientes oncologicos, inventario general o dataset de grocery para alinearlas con cancer de medula osea, abastecimiento preventivo e insumos clinicos y alimentos esenciales.

28. Corregir cualquier parte donde el informe sugiera que clinica y logistica son independientes. La frase clave que deberia repetirse es: la prioridad clinica funciona como indicador de presion asistencial para anticipar la demanda de recursos.